

Limpieza de sanitarios, pisos, mobiliario y cierre

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Ordenar el trabajo ambiental para impedir cruces entre áreas sucias y superficies asistenciales.

2. Alcance y condiciones de uso

Limpieza rutinaria y profunda de ambientes reales de la sede. No sustituye protocolos de equipos o instrumentos.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Asignar mapa de áreas, frecuencia y responsables

Asignar mapa de áreas, frecuencia y responsables. Separar paños, baldes y utensilios por sanitario y áreas de atención; señalar sin inventar un código de color obligatorio universal.

2. Retirar residuos por ruta definida y despejar el área

Retirar residuos por ruta definida y despejar el área. Evitar barrido seco que disperse suciedad y mantener a usuarios alejados del piso húmedo.

3. Limpiar mobiliario y puntos de alto contacto de arriba abajo y de limpio a sucio

Limpiar mobiliario y puntos de alto contacto de arriba abajo y de limpio a sucio. Usar fricción y producto compatible, cambiando utensilio cuando esté contaminado.

4. Limpiar sanitario con utensilios exclusivos: lavamanos, grifería, superficies y sanitario

Limpiar sanitario con utensilios exclusivos: lavamanos, grifería, superficies y sanitario según secuencia local. No llevar el paño de sanitario a camilla o equipo.

5. Limpiar piso hacia salida y controlar humedad, enjuague y secado

Limpiar piso hacia salida y controlar humedad, enjuague y secado. Desinfectar cuando matriz de riesgo lo prevé, respetando contacto sin crear superficies resbalosas.

6. Al terminar procesar utensilios, dejar secos y almacenar separados

Al terminar procesar utensilios, dejar secos y almacenar separados. Verificar área, registrar tareas efectivas y mantener cerrado el espacio que conserva riesgo o contaminación.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Cierre diario y limpieza cuando suciedad lo requiere.

Profunda según programación por área.

Nunca eliminar señalización antes de piso seguro.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Área y fecha	
Tarea y frecuencia	
Utensilio asignado	
Detergente y desinfectante	
Concentración contacto	
Hora de ejecución	
Condición de piso	
Ejecutor	
Verificador	
Corrección	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576